

注射用骨肽联合红花注射液治疗骨关节病疗效分析

李兰珍

【关键词】骨关节病;注射用骨肽;红花

骨关节炎是以软骨丢失伴有周围骨反应为特点的关节病,又称为骨关节病,退行性骨关节病或肥大性骨关节炎,是以生于中年以后的慢性退行性骨关节病,常累及负重关节及手指小关节,以关节软骨变性,关节边缘骨刺形成及软骨骨质硬化,囊性变为特点,临床表现为关节痛,僵硬,变形,活动受限,发病率随年龄而增高,女性多于男性。

1. 临床资料

2007年3月—2009年4月住院病人60例,男25例,女35例,年龄50—75岁,病程2月—16年,其中老年性骨质疏松症15例,多表现颈椎病,腰椎或四肢关节骨关节病。

2. 病例标准

临床上表现为关节疼痛,压痛,骨性隆起或肥大,关节肿胀或积液,晨僵,功能障碍或畸形,关节疼痛与X线显示程度不成比例。

3. 治疗方法

治疗组临床上用5%葡萄糖注射液250ml+注射用骨肽(黑龙江珍宝岛制药有限公司)、5%葡萄糖注射液250ml+红花注射液15ml静滴,7—10天为一疗程;对照组:七叶皂甙,灯盏花素分别加入5%葡萄糖注射液250ml中静滴,两组均口服布洛芬片,维生素B₁片以止痛,营养神经治疗。

4. 疗效标准

治愈,疼痛,肿胀消失,关节功能改善。

有效:疼痛,肿胀减轻,关节功能有所改善;无效:疼痛,肿胀无减轻,关节功能无改善。

治疗组:治愈 30例 有效 20例 无效 10例

对照组:治愈 20例 有效 20例 无效 20例

讨论:骨性关节炎是由于各种原因导致关节软骨的慢性退行性变,以软骨增生,破坏,关节疼痛,肿胀,功能障碍为主要表现,现代医学认为,本病以病早中期与关节软骨滑膜病变关系较为密切,软骨病变的退变产物可刺激滑膜产生疼痛,而滑膜炎症及滑膜遭受刺激后产生的反应性慢性炎症进一步引起软骨退行病变,并导致关节周围软组织,一系列病理改变而引发疼痛,而骨肽注射液为新鲜或冷冻的猪四肢骨提取的骨肽溶液制成的无菌冻干品,含有多种骨代谢的活性肽类,具有调节骨代谢,刺激成骨细胞增殖,促进新骨形成,以及调节钙磷代谢,增加骨沉积的作用,防治骨质疏松,止痛,消炎,调节代谢,促进骨愈合,红花注射液为中药红花提取物,具有扩张血管,改善微循环的作用,二者联合治疗骨关节病,疗效显著,临床上值得推广应用。

(作者单位:云南省楚雄州南华县医院中西医结合科 675200)

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

李喆¹ 莫琳芳²

【关键词】喹诺酮类

喹诺酮类药物为临床常用抗感染药,对其不良反应及药物相互作用尤为引起注意^[1,2]。喹诺酮类药物是人工化学合成药物,自20世纪60年代合成第一个喹诺酮药物以来,人们对喹诺酮类药物不断进行结构修饰,使得该类药发展迅速,至今已有许多新品种应用于临床,因抗菌谱广在临床上应用越来越广泛,近些年发现喹诺酮类药物还有抗结核杆菌作用,可与异烟肼、利福平合用于治疗结核病,由于该类药抗菌谱广、抗菌活性强、给药方便等特点,临床应用较广泛,同时相关的一些不良反应报道也日渐增多。本文结合我院实际临床病例及查阅文献总结发现喹诺酮类药物临床表现不良反应多,可累及人体多个系统,并与多种药物发生相互作用。现概述如下。

1. 不良反应

1.1 对中枢神经系统(CNS)^[3]的作用 到目前为止,仍不能确切了解喹诺酮类药物对CNS作用的分子靶位或受位。中枢神经毒性反应包括头痒、眩晕、疲倦、失眠、视觉异常和噩梦,严重的神经毒性作用很少。一般报道病人的发病率在10%以上,且女性比男性的发病率要高。

1.2 胃肠道反应是喹诺酮类药物最常见的不良反应之一,主要表现为:恶心、呕吐、腹泻、食欲不振及消化不良等,有的患者还有黄疸,血清转氨酶升高,对肝脏有一定毒性。

1.3 皮肤过敏反应及光毒性 使用喹诺酮类药物后,个别患者可能出现光敏反应或严重过敏反应。如皮肤潮红、瘙痒、皮疹、红斑、血管性水肿等,停药后症状大都消退。光敏反应好发于女性,陶然^[4]等报道,3例女性泌尿系统感染患者,给司帕沙星片0.2g qd po 5天。在服药4天出现手背、颜面部皮肤明显的均匀色素沉着,可能由于沉着在皮下的药物,引起局部皮肤的炎症性反应,经紫外线照射后出现皮肤的色素沉着,因而服药期间应避免长时间暴露在阳光下。

1.4 心血管系统、泌尿系统的不良反应 对心血管表现为心慌、心悸、血压升高、心肌缺血、心肌炎,有时伴有心律失常,对心脏有一定的毒性;对泌尿系统表现为肾毒性,引起结晶尿、血尿、尿素氮升高,可发生肾炎、急性肾功能衰竭等。

1.5 肝脏毒性^[5]这方面的报道,以NFLX报道较多。李国萍等报道,口服NFLX引起巩膜黄染,经检查胆红素最高达到

324 $\mu\text{mol/l}$ ALT高达 8335 $\mu\text{mol/l}$ B超、CT检查排除为胆道疾病,确诊为肝细胞受损。故应用本品时应监测肾功能。

1.6 肌腱病变表现为生化指标异常(如谷丙、谷草转氨酶升高)、巩膜及皮肤黄染。

1.7 软骨毒性 资料来源主要为萘啶酸、诺氟沙星和环丙沙星。儿童及青少年长期服用此类药物,可能由于其对关节软骨的损害导致生长发育受阻。主要影响新生或幼小动物的骨骼增长板(除骺一关节复合体外)。一般为一过性、可逆性改变,对症处理或停药即可缓解。

1.8 其他 极少有报道发生球后视神经炎、溶血性贫血、颅内压升高等。

2 药物相互作用

2.1 氨基糖苷类 这两类药物对于革兰阴性菌均有良好的抗菌活性,通过抑制 DNA 回旋酶并阻碍细胞蛋白质合成的双重作用方式以发生其协同作用,尤其在用于大肠杆菌引起的感染时药效增加。

2.2 β -内酰胺类 β -内酰胺类可阻碍细胞壁粘肽的合成,造成细胞壁缺损,从而使喹诺酮类易于发挥杀菌作用。

2.3 利福平 利福平是肝药酶诱导剂,而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用,合用后致使喹诺酮类抗菌活性降低,甚至消失。

2.4 其它抗菌药类合用使药效相加^[1]与磺胺嘧啶合用,明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金葡菌的作用^[2]。环丙沙星与抗结核药物联用对非典型的分支杆菌具协同作用^[4]。诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐药伤寒,疗效优于单用诺氟沙星者,同时对绿脓杆菌引起的感染亦有良好疗效。合用使毒副作用增加的有:^[1]喹诺酮类药物与氯霉素、红霉素合用可导致效用降低,不良反应加重^[2]。环丙沙星与阿霉素、万古霉素、呋喃妥因合用,增加了其毒性,并且对肾功能不全者损害更大。

3. 用药原则

3.1 严格控制用药指征 应严格掌握其适应证,合理选用药

物、剂量、给药途径,防止滥用。有过敏史者应慎用,高敏体质者禁用。基于某些特定 ADR, 18岁以下的禁用。

3.2 预防为主? 临床使用中严格掌握适应证,疗程不宜过长,用药过程中应严密监视,发现 ADR 后要尽快采取措施,及时停药及对症治疗。

3.3 老年人用药慎重 要适应减少剂量,因喹诺酮类药物有 45%~60%以原型经尿液排出。老年人肾血流量明显下降,对药物排泄也相应减少,同样的剂量会造成体内药物浓度增高。

目前临床应用抗感染药种类繁多,喹诺酮类药物以其广谱、高效、安全、使用方便的特点广泛应用于临床。然而 ADR 也不容忽视,据专家统计,抗感染药处方中有 50%以上没必要或使用不当,滥用程度更甚。因而明确药物耐药性、不良反应、相互作用与明确疗效同样重要。

参考文献

- [1] 方翼. 3种氟喹诺酮类药物抗生素后效应的研究. 中国抗生素杂志, 1997, 22(1): 67.
- [2] 江复. 氟喹诺酮类药物临床应用进展. 中华内科杂志, 1999, 38: 65.
- [3] 吴荷芳. 氟喹诺酮类药物不良反应分析. 中国医院药学杂志, 1999, 19(12): 765.
- [4] 陶然. 司帕沙星致日光性皮炎 1例. 中国新药杂志, 1999, 8(6): 369.
- [5] 陈术辉. 喹诺酮类抗菌药的联合用药与不良反应. 湖南医学, 1997, 1(6): 369.
- [6] 刘洪云. 环丙沙星合并用药的相互作用. 中国医院药学杂志, 1996, 16(10): 444.

(作者单位: 1新疆乌鲁木齐市军区机关医院 830000; 2海军医学研究院 200000)

中药不良反应原因分析与安全用药管理

张建祥

【摘要】目的:分析中药不良反应发生的原因,为安全用药管理提供参考。方法:统计我院 2008年 1月——2009年 2月发生中药不良反应的临床资料,分析发生不良反应的主要原因。结果:本组 700份资料中,发生不良反应 32例,主要原因是超量使用、个体差异、剂型因素、人为因素、药物自身因素。结论:分析中药的不良反应发生原因并针对性的加强用药管理,提高用药安全性。

【关键词】中药;不良反应;安全用药

药物不良反应是指按正常用法、用量应用药物预防、诊断或治疗疾病过程中,发生与治疗目的无关的有害反应,给病人带来不适或痛苦^[1-2]。本文主要探讨我院中药不良反应发生的原因,以期为临床上进行安全用药管理提供参考。现将相关的临床资料总结并报道如下。

1. 资料与方法

1.1 资料来源。随机抽取我院 2008年 1月——2009年 2

月门诊开具的中药处方 700份(从每月的中药处方中随机抽取 50份),其中中药制剂发生不良反应的 32份发生率为 4.6%。

1.2 分析方法。采用描述性方法,统计发生不良反应的 32份资料中,患者的性别、年龄、不良反应涉及的器官系统以及发生不良反应的原因,并将依据病例数多少对引发不良反应的原因进行排序。